Control del dolor oncológico de origen ginecológico

Dolor en ginecología y paciente obstétrica

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Dolor agudo en el cáncer ginecológico

   Dolor refractario.
   Manejo no farmacológico para controlar el dolor.

4. Dolor agudo tras cirugía oncológica

5. Dolor agudo tras tratamiento con quimioterapia

6. Dolor crónico

7. Conclusiones

8. Bibliografía

Objetivos

- Describir los diferentes tipos de dolor tras un cáncer ginecológico.
- Identificar las causas más frecuentes del dolor agudo y el crónico en el cáncer ginecológico y las posibles alternativas de tratamiento farmacológico y no farmacológico.

Introducción

El cáncer es una de las enfermedades que ocasiona un crecimiento descontrolado de las células de cualquier parte del cuerpo y puede propagarse. Es, junto a las enfermedades del corazón, una de las mayores causas de muertes en los Estados Unidos. Según la OPS, el cáncer uterino es el segundo más común en las mujeres de Latinoamérica y el Caribe, con 35 000 muertes y 83 000 mujeres diagnosticadas cada año (1).

En la población femenina, el cáncer de ovario se posiciona en el tercer cáncer ginecológico más frecuente. Sin embargo, es el que presenta el peor pronóstico, siendo tres veces más letal que el cáncer de mama. Menos de la mitad de las mujeres afectadas por la enfermedad llegan a vivir más de cinco años después del diagnóstico inicial. La mayoría de las pacientes son diagnosticadas con mayor frecuencia después de la menopausia y en una etapa avanzada. Las causas de la enfermedad se asocian a factores genéticos y hormonales (2).

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, por sus siglas en inglés), el dolor se define como "(…) una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en un tejido, o descrito en términos de dicho daño". Este síntoma es uno de los más frecuentes en personas con cáncer y difiere en sus características con el que experimentan personas sin cáncer (3).

El dolor es el principal síntoma que se presenta en el 40 % de los pacientes oncológicos en tratamiento, y en entre el 80 % y el 85 % de pacientes con la enfermedad avanzada. El 5-10 % de ellos desarrollará dolor crónico afectando seriamente su calidad de vida. En el caso del cáncer ginecológico, concretamente, la incidencia del dolor se presentará aproximadamente en el 22-38 % de las pacientes (4) (Figura 1).

Las pacientes con cáncer ginecológico pueden presentar varios tipos de dolor: dolor agudo, por el proceso maligno o secundario al tratamiento de quimioterapia; o tras la intervención quirúrgica y dolor crónico, secundario al proceso maligno o secuelas del tratamiento.

Dependiendo de diferentes factores, se pueden distinguir diferentes tipos de dolor oncológico (5):

- Clasificación del dolor según la duración:
  - El **dolor agudo** es la sensación dolorosa limitada en el tiempo (ejemplo: fractura de un hueso).
  - El **dolor crónico** es el dolor típico del paciente con cáncer. Se define como aquel que dura más de 3 meses. Es frecuente que este tipo de dolor cause alteraciones psicológicas en los pacientes (depresión y otras alteraciones del estado de ánimo).
- Clasificación del dolor según la causa genérica. En estos rasgos se pueden distinguir (5):
  - **Dolor por crecimiento e infiltración del tumor:** es la causa más frecuente de dolor en los pacientes con cáncer. Las características del dolor van a depender del tipo de estructura que se infiltra (huesos, vísceras o nervios).
  - **Dolor asociado al tratamiento del cáncer:** dolor postquimioterapia, postradioterapia, postoperatorio, tras pleurodesis, asociado a procedimientos diagnósticos.
  - Dolor asociado al debilitamiento general del paciente.

Figura 1. Dolor de causa ginecológica. Tomado de: 123 RF. 47883806.

- **Dolor concomitante no canceroso:** un paciente con diagnóstico de cáncer puede padecer dolor por otra causa no asociada con su enfermedad oncológica.

- Clasificación del dolor según tipos de dolor oncológico (5):
  - **Somático o nociceptivo:** por estimulación de nociceptores cutáneos y de tejidos profundos como el hueso. Es un dolor constante y bien localizado. Son ejemplos de este tipo de dolor las metástasis óseas y el dolor de las incisiones postquirúrgicas.
  - **Visceral:** como resultante de la infiltración, compresión, distensión o estiramiento de vísceras torácicas y abdominales por afectación primaria o metastásica. Es un dolor mal localizado y, a menudo, referido a la piel. Puede asociarse a síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, sudoración y, sobre todo, el dolor agudo.
  - **Neuropático:** por afectación de los nervios periféricos, plexos o médula espinal, a causa de infiltración, compresión tumoral, o secundario a la quimioterapia, radioterapia o cirugía. Es un dolor paroxístico, quemante, eléctrico, sordo, urente o lancinante; acompañado de parestesias, disestesias, hipo e hiperestesia, así como de alteraciones motoras, sensitivas y del Sistema Nervioso Autónomo.
  - **Mixto:** con características de dolor nociceptivo y neuropático, es el tipo de dolor más frecuente en los pacientes oncológicos *(Figura 2)*.

Dolor agudo en el cáncer ginecológico

- **Etiología**

  El dolor se va a producir por una acción combinada entre el proceso neoplásico, el sistema inmune y el sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP). Las células neoplásicas van a producir sustancias que estimulan la proliferación del sistema inmune y el desarrollo del sistema nervioso hacia el proceso neoplásico. Como consecuencia de ello, se producirá la destrucción de tejido y la producción de neuromoduladores, los cuales sensibilizarán y activarán el SNP y SNC, aumentando el dolor en los pacientes con cáncer *(Figura 3)*.

  No obstante, otros factores contribuirán a aumentar la percepción del dolor, como son: factores psicológicos, sociales o físicos, y es que muchas de las pacientes, tras ser diagnosticadas de un proceso oncológico, sufrirán altos niveles de estrés y ansiedad.

- **Manejo terapéutico**

  Para lograr el control de dolor en los pacientes con cáncer, es necesario que el personal de salud se familiarice con la patogénesis de dolor oncológico, las técnicas de evaluación, el tratamiento farmacológico y no farmacológico y las barreras que se presentan para brindar una adecuada analgesia (3).

  La escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el algoritmo más usado para el tratamiento de dolor oncológico (3). Propone el uso de esta escalera analgésica de forma pautada, con la correspondiente titulación de la necesidad de analgésicos, así como de los tratamientos coadyuvantes necesarios. Ya que estandarizar correctamente los tratamientos, y evaluar su respuesta, es imprescindible para el control del dolor (3) *(Figura 4)*.

  Los opioides son efectivos para el dolor oncológico moderado-severo, por lo que son considerados como tratamiento de primera línea. Además, tienen la ventaja de presentar efectos adversos predecibles, y una gran variedad de vías de administración: oral, intravenosa, subcutánea, intranasal, epidural, intratecal, transdérmica, submucosa, intraarticular e inhalada (5). Por ello, sería interesante valorar de forma individualizada cada paciente, asociando fármacos no opioides y otras terapias no farmacológicas, para reducir las dosis necesarias de opioides. El efecto de los opioides en la progresión tumoral está relacionado con la habilidad que tienen de interferir con la integridad de la barrera hematoencefálica, su potencial angiogénico en las células tumorales y su efecto inmunosupresor directo.

  En el mecanismo por el cual este grupo de fármacos induce inmunosupresión se reconocen los receptores μ. Su estimulación incrementa la producción de hormona adrenocorticotrópica, incremento de cortisol y la consecuente respuesta inmunosupresiva, tanto con opioides naturales como sintéticos. De esta forma, promueven la progresión tumoral con evidencia demostrada (6).

  Respecto al tratamiento con AINES y paracetamol, estos se han asociado para tratar el dolor oncológico más leve o en pacientes con contraindicaciones médicas, o para poder reducir las dosis de opioides administradas. Los AINES, aunque la evidencia encontrada en la literatura es baja, parecen mejorar el dolor oncológico moderado-severo. Sin embargo, con el paracetamol no se observó mejoría del dolor, y todos los pacientes precisaron tomar opioides.

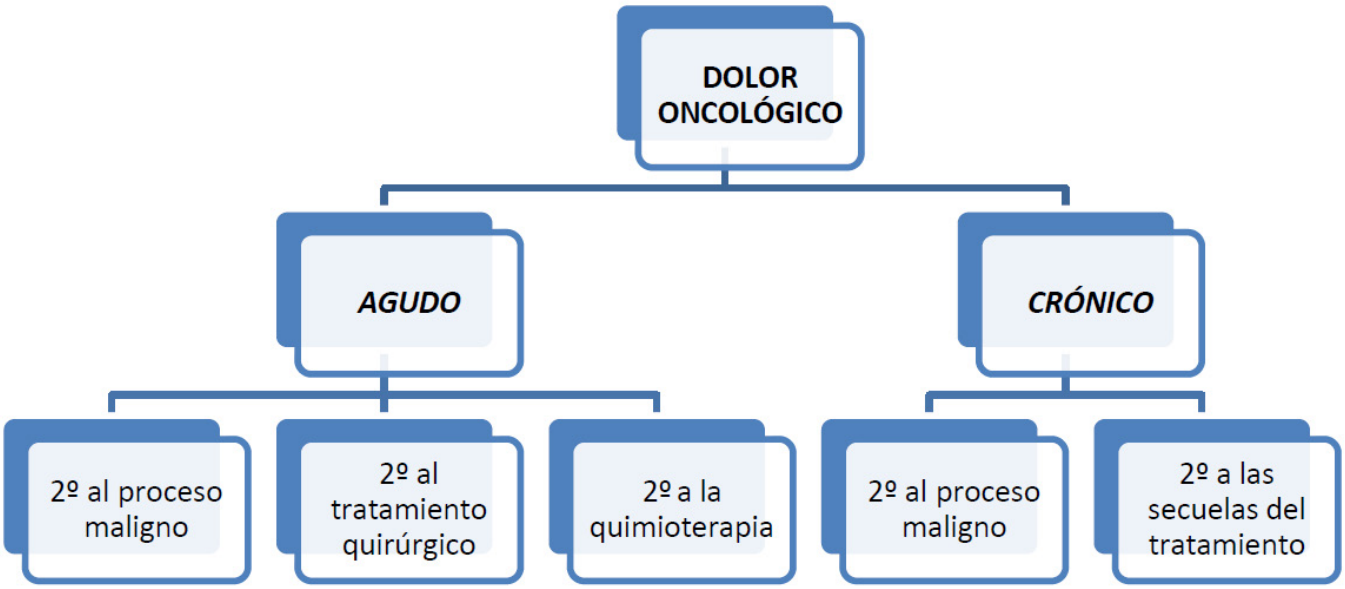

Figura 2. Tipos y causas del dolor oncológico. Tomado de: elaboración propia.

Figura 3. Etiología del dolor agudo oncológico. Tomado de: elaboración propia.

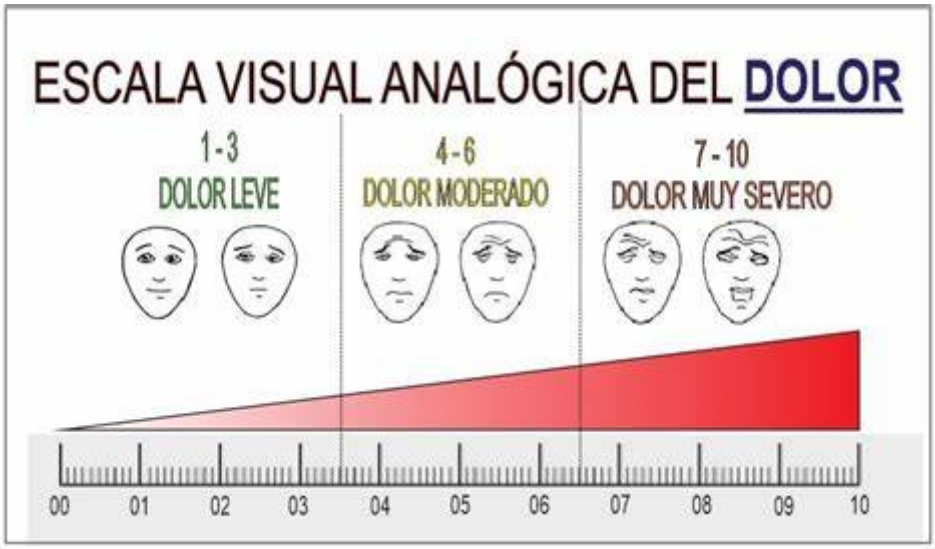

Figura 4. Escala visual analógica del DOLOR (EVA). Tomado de: Kerozt. Escala visual analógica del DOLOR (EVA) – KEROZT.

El 20-40 % de las pacientes oncológicas también presentarán dolor neuropático, en parte, por el mismo proceso cancerígeno y, también, de forma secundaria al tratamiento oncológico. El dolor neuropático es frecuente en los pacientes con cáncer y es de difícil manejo, puede ser causado por infiltración tumoral, síndrome paraneoplásico o secundario a polineuropatía inducida por el tratamiento (3).

Los tratamientos que se utilizarán en estos casos serán anticonvulsivantes (gabapentina y pregabalina), antidepresivos tricíclicos (ATC) inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ketamina o analgésicos locales (3) *(Figura 5 y 6).*

Figura 5. Medicamentos vía oral. Tomado de: 123 RF. 92655501

Figura 5. Medicamentos vía oral. Tomado de: Sin fuente.

La gabapentina y la carbamazepina ofrecen un adecuado alivio del dolor neuropático (66 % de los pacientes). Con la administración combinada de un opioide + gabapentina para el control del dolor, se han observado efectos adversos, como son: boca seca, constipación y sedación, en pacientes oncológicos (5).

Tras recibir el tratamiento adecuado, las pacientes, además de mejorar su dolor por la lesión nerviosa o daño óseo, pueden también experimentar mejoría en el sueño, calidad de vida, precisando menores dosis de opioides y mostrar mayor satisfacción en general.

Respecto a la pregabalina, aunque se disponen de menos estudios, también ha demostrado su eficacia, así como también se ha observado un menor requerimiento de opioides por parte de las pacientes. Por lo tanto, ambos fármacos, la gabapentina y la pregabalina, son tratamientos adecuados para el dolor neuropático en estas pacientes (5).

Respecto a los antidepresivos tricíclicos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, los resultados de los estudios disponibles no son tan robustos como con los anticonvulsivantes. Por otra parte, también se han utilizado los cannabinoides con resultados satisfactorios, permitiendo reducir la dosis de opioides y analgésicos locales, como el ketorolaco en crema y ketamina tópica para control del dolor neuropático tras la quimioterapia.

Dolor refractario

Cerca del 10 % de los pacientes con cáncer presentan dolor de difícil manejo, incluso con tratamiento parenteral. En este contexto, son útiles algunas técnicas invasivas como bloqueos nerviosos y administración medicamentosa espinal o epidural (3) *(Figura 7).*

En algunos casos, las pacientes no presentarán mejoría con los tratamientos conservadores o farmacológicos por lo que se podrían utilizar técnicas invasivas, como la analgesia epidural e intradural. Es preferible la analgesia intratecal, por la infusión de menores dosis de anestésicos locales u opioides (morfina), así como la menor incidencia de efectos secundarios.

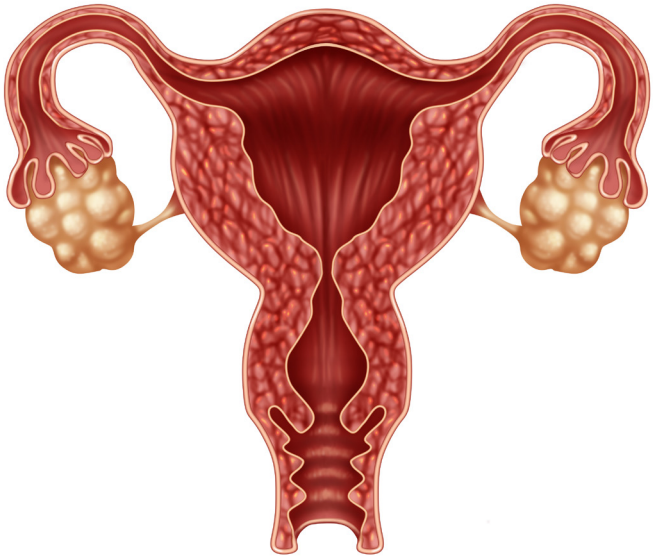

Figura 7. Cáncer de útero. Tomado de: 123 RF. 68628697.

- **Administración de medicamento vía intratecal**

  La dosis requerida de opioides por vía espinal es 20 a 40 % de la dosis sistémica para alcanzar equianalgesia, y solo del 10 % si se realiza vía intratecal. Esta vía debe considerarse en pacientes con dolor en varias regiones anatómicas, inadecuado control de dolor a pesar de dosis incrementales de opioides sistémicos, falta de respuesta a cambio de opioide o ruta de administración, aumento de efectos adversos o expectativa de vida mayor a seis meses.

  El sistema implantable tiene menos riesgo de infección y menores requerimientos de mantenimiento comparado con el percutáneo. Sin embargo, su posicionamiento es más complejo. Estas estrategias están contraindicadas en pacientes con infecciones, coagulopatía o con expectativa de vida muy corta (3).

- **Bloqueo de nervio periférico**

  Los bloqueos de nervios periféricos o plexos pueden ser usados cuando el dolor ocurre en el campo de uno o más nervios periféricos, o si el dolor es causado por complicaciones como fracturas patológicas u oclusiones vasculares. Generalmente, es usado como coadyuvante de analgesia sistémica. El uso de agentes neurolíticos en los nervios periféricos puede producir neuritis, lo que en pacientes con buen pronóstico puede resultar contraproducente, pues, los síntomas pueden ser más difíciles de manejar que el dolor original (3).

- **Bloqueo neurolítico**

  El bloqueo neurolítico debe limitarse a aquellos pacientes con una corta expectativa de vida, pues el efecto del bloqueo tiene una duración de tres a seis meses. Este bloqueo permite disminuir el uso de analgésicos sistémicos para el control del dolor visceral. Esta técnica es usada para el plexo hipogástrico superior y para el plexo celiaco (especialmente en cáncer de páncreas). Ha demostrado ser efectiva, incluso, sobre la terapia sistémica, con una duración de seis meses (3).

Manejo no farmacológico para controlar el dolor

Teniendo en cuenta que el dolor afecta las dimensiones física, psicosocial y espiritual, el tratamiento del dolor oncológico requiere la integración de terapias dirigidas a estos aspectos, incluyendo la terapia cognitivo-comportamental. Las medidas físicas incluyen masaje, uso de calor o frío, acupuntura y acupresión. Las intervenciones cognitivas están dirigidas a fortalecer el sentido de control sobre el dolor o la enfermedad de base. Otras estrategias como ejercicios de respiración, relajación, hipnosis y otras terapias comportamentales pueden ser útiles (3).

La atención también debe enfocarse en el soporte psicosocial, brindando educación a pacientes y familiares. En el cuidado del paciente con cáncer, se debe tener en cuenta las necesidades espirituales del paciente, por lo que la atención espiritual debe incluirse como un componente del manejo integral del dolor (3) *(Figura 8 y 9).*

}Otras técnicas que no han sido confirmadas que mejoren el dolor, pero podrían utilizarse en estos casos de forma individualizada, son: la acupuntura, la estimulación por ultrasonidos o estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS).

}La neuromodulación también ha sido una técnica utilizada en el dolor oncológico mediante la estimulación transcraneal, a nivel del nervio periférico (*n.* ilioinguinal, *n.* iliohipogástrico y *n.* genitofemoral), en los ganglios de las raíces dorsales o a nivel de la médula espinal.

}No obstante, es recomendable que el tratamiento en estas pacientes sea un tratamiento multidisciplinar, para controlar no solo el dolor, sino también las consecuencias psicológicas de sufrir un proceso oncológico.

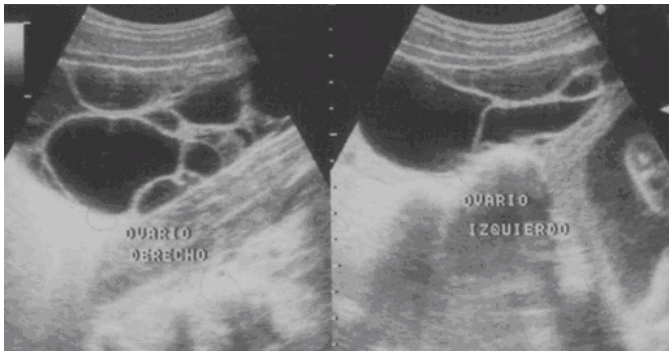

Figura 8. Ecografía de cáncer de ovarios. Sin fuente.

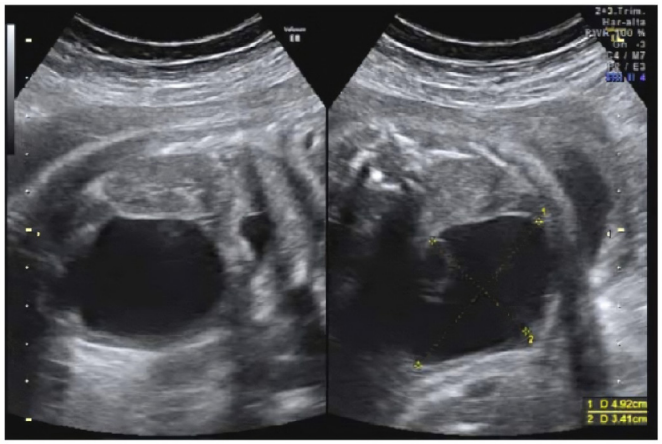

Figura 9. Ecografía de cáncer de ovarios. Tomado de: ecografía de cancer de ovarios - Bing images.

Dolor agudo tras cirugía oncológica

En muchas ocasiones, las pacientes que padecen un cáncer ginecológico van a requerir realizar una intervención quirúrgica para su tratamiento, por lo que se tendrá que valorar el nivel de dolor en el postoperatorio y pautar la analgesia adecuada en cada caso *(Figura 10 y 11).*

Es importante recordar que el tratamiento del dolor agudo postoperatorio requiere un abordaje multimodal, asociando anestesia regional, analgésicos de acción central, como el paracetamol, y de acción antinflamatoria periférica; opioides a través de una de sus múltiples vías de administración, junto con fármacos coadyuvantes como los destinados al dolor de tipo neuropático (6).

Figura 10. Cancer de Cérvix. Sin fuente.

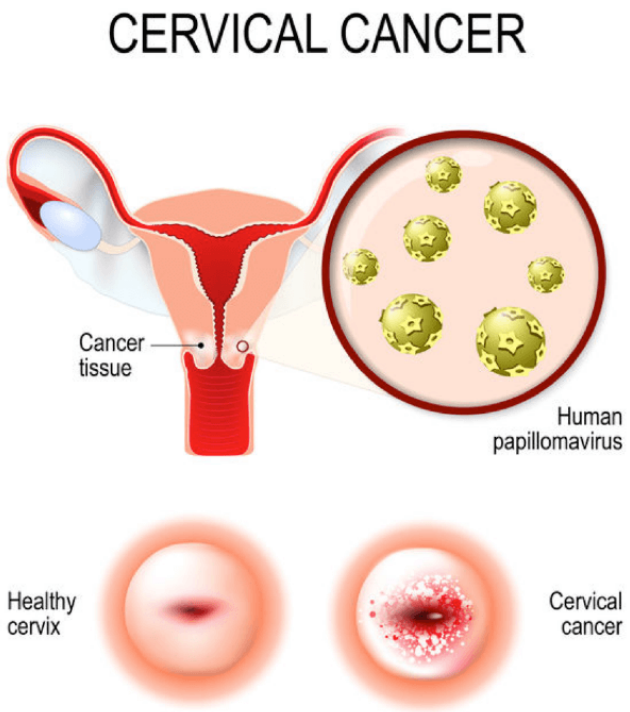

Figura 11. Cancer de Cérvix. Tomado de: 123 RF. 96534314

Un buen manejo del dolor postoperatorio se ha asociado a la disminución de complicaciones cardiopulmonares, mortalidad hospitalaria, estancia y costes hospitalarios. Tradicionalmente, los opioides han sido los fármacos empleados con mayor frecuencia en el postoperatorio de estas pacientes, con el consecuente riesgo de dependencia y efectos secundarios que ello supone.

La gabapentina y pregabalina como un componente de la analgesia multimodal. Ambos medicamentos disminuyen el requerimiento de opioides y disminuyen el dolor postoperatorio, especialmente cuando son administrados antes de la cirugía. La administración conjunta de gabapentina prequirúrgica, bupivacaína liposomal intraoperatoria en la incisión quirúrgica y analgésicos no opioides en el postoperatorio reducen las dosis de opioides en el postoperatorio de estas mujeres con cáncer ginecológico. Por otra parte, la combinación de AINES y paracetamol o AINES y oxicodona mejoran el dolor postoperatorio de estas pacientes (7).

No obstante, lo más recomendable en estos casos es realizar un abordaje multimodal del dolor, el cual va a acelerar la recuperación postoperatoria de estas pacientes, con una reducción de su morbilidad. El uso de dos o más técnicas analgésicas, con mecanismos de acción diferentes, ayudarán a controlar mejor el dolor.

Estas técnicas incluyen bloqueos nerviosos, infiltración de la herida quirúrgica, analgesia epidural con anestésicos locales y/u opioides, así como la administración de AINES u opioides intravenosos o por vía oral. Respecto a la analgesia epidural, controlada por la paciente, (PCEA) en comparación con la analgesia intravenosa controlada por la paciente (PCA), la PCEA controla mejor el dolor postoperatorio con menos efectos secundarios, como es la sedación o la depresión respiratoria; por lo que va a suponer una técnica más segura.

Como bloqueos nerviosos, se debe destacar el bloqueo del plano transverso del abdomen (TAP), sobre todo cuando la incisión de la cirugía sea vertical. Con el TAP se bloquearán los nervios que inervan la zona anterior del abdomen (T6-L1), lo que supondrá la disminución del consumo de opioides durante las primeras 24-48 h del postoperatorio y se evitarán los posibles efectos secundarios de la anestesia neuroaxial (hematoma espinal, depresión respiratoria, etc.).

El objetivo, en todo caso, es que la paciente se encuentre lo más cómoda posible y que inicie una deambulación precoz, disminuyendo en lo posible la dosis de opioides utilizadas y ajustando la medicación en cada caso de forma individualizada.

El dolor postoperatorio tiene un alto impacto. Es una de las principales causas médicas de retraso en el alta hospitalaria. El manejo del dolor agudo postoperatorio continúa siendo un problema en Latinoamérica. Muchos pacientes refieren dolor moderado o severo tras la cirugía, lo que puede conducir a dolor crónico (8).

Dolor agudo tras tratamiento con quimioterapia

La quimioterapia va a formar parte del tratamiento de muchas de estas pacientes, y uno de los efectos secundarios que va a producir es el dolor neuropático a nivel de los nervios periféricos. Típicamente, se presenta como pérdida de sensibilidad en manos y pies; pero, también, se puede acompañar de alteración autonómica o motora. El mecanismo exacto se desconoce, pero se han descrito algunos factores de riesgo que podrían estar relacionados: la diabetes, neuropatías previas, edad, genética, dosis de quimioterapia, bajos niveles de actividad física, etc.

Como medidas preventivas destacan: la administración de vitamina *E* (antioxidante) y glutamina (aminoácido no esencial), los cuales han demostrado su efecto neuroprotector en algunos estudios. Sin embargo, estos estudios tienen un limitado valor metodológico, por lo que su uso regular en la práctica clínica no está generalizado.

Respecto al tratamiento utilizado en estos casos, se han descrito estudios con ATC (amitriptilina), inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (duloxetina), gabapentina, ketamina, gel de baclofeno o el uso de la acupuntura. De ellos, se puede destacar que la duloxetina demostró una alta evidencia en controlar este tipo de dolor. Sin embargo, con el resto de tratamientos, la evidencia fue baja. No obstante, los opiáceos se suelen utilizar en este tipo de dolor, a pesar de la escasa evidencia demostrada.

Otro tipo de dolor, producido por la quimioterapia, serán las artralgias y mialgias, sobre todo con los taxanos. Fármacos como los corticoides, glutamina o gabapentina se han utilizado para su tratamiento, sin embargo, no hay estudios que demuestren sus beneficios.

Uno de los tratamientos asociados a la quimioterapia será el factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), el cual puede producir dolor óseo, siendo el tratamiento de elección, en estos casos, los AINES *(Tabla 1).*

Dolor crónico

El dolor crónico es aquel que persiste más allá del tiempo de recuperación de una lesión, o aquel que se mantiene o recurre más allá de tres meses. Cuando el dolor agudo no es tratado correctamente, puede cronificarse. El dolor crónico se considera una enfermedad propiamente dicha y debe ser tratado según su etiología (9).

El dolor crónico en la paciente oncológica puede desarrollarse por múltiples causas, incluso, por el mismo tratamiento que la paciente ha llevado, resultando en dolor crónico iatrogénico. Es por ello, que en algunas guías de tratamiento en estas pacientes recomiendan limitar el uso de opioides, así como no pautarlos de forma aislada, sino combinada con otros analgésicos.

Por otra parte, las pacientes, tras la cirugía, también pueden presentar dolor crónico a nivel del abdomen, espalda o pelvis. Este dolor podría ser causado por el atrapamiento de algún nervio, el cual podría beneficiarse de un bloqueo nervioso con anestesia o liberación quirúrgica del nervio en caso de no responder al bloqueo nervioso. El dolor no es solo nocicepción, también implica las esferas psicológicas y sociales, por lo que el manejo exitoso del dolor crónico requiere abordar todas las condiciones físicas y psicológicas desagradables (9).

El tratamiento quirúrgico es considerado, en muchos casos, como terapia para la resección de tumores sólidos. La cirugía en el paciente oncológico generalmente tiene intensión curativa en dependencia del estado del paciente y la evolución de la enfermedad. No obstante, para lograr esto, se debe realizar la extirpación completa del tumor, con márgenes libres, sin enfermedad macroscópica residual, y una linfadenectomía adecuada, además de mínima manipulación tumoral posible (6).

Dolor neuropático *n*. periférico	Prevención: vitamina *E;* glutamina
	Tratamiento: IRSN (Duloxetina); ATC; gabapentina; ketamina; el baclofeno; acupuntura
Artralgias/ mialgias (Taxanos)	Tratamiento mialgias / artralgias; corticoides; glutamina; gabapentina
Dolor óseo (G-CSF)	Tratamiento dolor óseo: AINES

Tabla 1. Manejo terapéutico del dolor agudo tras tratamiento con quimioterapia en patología oncológica ginecológica. Tomado de: elaboración propia.

A pesar de conseguir estos objetivos tras la exéresis tumoral quirúrgica, puede quedar enfermedad residual no visible o micro metástasis con potencial crecimiento y diseminación, lo que causa recurrencia del tumor, incluso tras una cirugía curativa (6).

El dolor y disfunción del suelo pélvico, por el desarrollo de patología musculoesquelética, es otra de las situaciones que se pueden encontrar en estas pacientes oncológicas; apareciendo áreas con cierta limitación funcional y contracción dolorosa (puntos "*trigger*"). Para su tratamiento, se puede aplicar una terapia multimodal con relajantes musculares, ejercicios de suelo pélvico e inyección de los puntos gatillos, principalmente con anestésicos locales y corticoides o toxina botulínica, de tal forma que se consiga un control analgésico adecuado mediante la desactivación de estos puntos dolorosos.

Además de la técnica quirúrgica, el periodo perioperatorio, el estrés quirúrgico y la anestesia general con la subsecuente respuesta neuroendocrina e inflamatoria, por sí mismos limitan la respuesta inmune y alteran el balance entre el potencial metastásico del tumor y antimetastásico de las defensas, incluyendo la inmunidad celular y células natural *Killer*, lo cual representa un mecanismo plausible de incremento de las metástasis y recurrencia oncológica, lo que afecta la supervivencia de estos pacientes (6). El manejo de esta patología requiere un abordaje multimodal que incluye combinaciones de terapias farmacológicas, no farmacológicas e intervencionistas (9).

La aplicación de radioterapia vulvar, cervical o endometrial, también podría producir dolor pélvico por la cistitis. Se recomienda, de entrada, tratamiento conservador (anticolinérgicos, antiespasmódicos), y si no responde, iniciar un tratamiento más agresivo con instilaciones vesicales de ácido hialurónico, toxina botulínica o terapia con oxígeno hiperbárico. En concreto, el dolor de la radioterapia a nivel vulvar podría beneficiarse también de ejercicios de suelo pélvico y de los bloqueos nervioso, así como del oxígeno hiperbárico como tratamiento del daño tisular.

Los pacientes con neuropatía periférica, producida por la quimioterapia, también tienen riesgo de desarrollar dolor crónico. Sin embargo, otros fármacos que pueden ser útiles para ayudar a disminuir la dosis de opiáceas podrían ser la amitriptilina, baclofeno, gel de ketamina o capsaicina, junto a la terapia física.

Todos los pacientes que reciban opioides neuroaxiales, deberán ser vigilados y monitorizados sobre su nivel de ventilación, oxigenación y, sobre todo, de su nivel de conciencia. Adecuando su duración en tiempo y en medios humanos y materiales, a la farmacocinética del opioide administrado, a la patología de base del paciente y medicación coadyuvante (farmacodinamia) y por último a la disponibilidad de personal sanitario entrenado para mantener un adecuado protocolo de vigilancia y actuación frente a la temida depresión respiratoria (6).

Tras la quimioterapia, radioterapia o cirugía, también puede presentarse dispareunia, la cual puede ser tratada con dilatadores vaginales, lubricantes o estrógenos, si no están contraindicados.

Conclusiones

El dolor se presenta en la mayoría de los pacientes diagnosticados con algún tipo de cáncer, exacerbándose dependiendo del compromiso y el tipo de neoplasia. Este tipo de dolor inadecuadamente tratado constituye un problema de salud pública, por lo cual, es primordial la exhaustiva evaluación para asegurar un manejo oportuno y adecuado desde el momento del diagnóstico, con seguimiento a intervalos regulares, en busca de identificar el mejor balance entre la eficacia y seguridad de las intervenciones, y alcanzar el principal objetivo de maximizar la funcionalidad y mejorar la calidad de vida del paciente. El manejo del dolor oncológico requiere, por lo tanto, un abordaje multidisciplinario, que involucre medidas dirigidas a intervenir tanto las dimensiones físicas, como las psicosociales y espirituales de los pacientes.

Bibliografía

1. Gálvez A. Conocimientos y prácticas preventivas sobre la infección por Virus del Papiloma Humano en mujeres de 20 a 25 años de edad. Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión, 2020 [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Obstetricia; 2021.
2. Araya Oviedo A, Paizano Vanega G. Cáncer de ovario Revista Médica Sinergia. Vol. 6, Núm. 7, julio 2021, e690. https://doi.org/10.31434/rms. v6i7.690
3. Ximena León M, Guillermo Santa-Cruz J, Martínez-Rojas S, Ibatá-Bernal L. Recomendaciones basadas en evidencia para el manejo del dolor oncológico. ARTÍCULO DE REVISIÓN Vol. 42. No. 1 enero-marzo 2019 pp 45-55. http://www.medigraphic.com/rma
4. Jennifer Jaimes, MD, Mario Andrés Leotau, MD, German William Rangel, MD, Nelcy Miranda. Efectividad del bloqueo neurolítico simpático abdominal en una serie de casos descriptiva en pacientes con dolor oncológico. 2020: 4(2). P23-42. DOI: 10.29375/01237047.3337
5. Díaz-Juvier Y, Hernández-Ortega Y, Hernández-Rodríguez L, Cuevas-Pérez O, Fernández-Ruiz D. Tratamiento del dolor en el paciente oncológico. Medisur [revista en Internet]. 2019 [citado 2021 Ago 22]; 17(4):[aprox. 9 p.]. Disponible en: http://medisur.sld.cu/index.php/medisur /article/view/4010
6. Ortega Valdés ME, López Garcia O, Fernández Martínez MJ. Perioperatorio y recurrencia oncológica: reto actual en la práctica anestésica. Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación. 2019;19(1):e525 https://creative commons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES
7. Dávila-Cabo-de-Villa E, Morejón-Hernández J, Acosta-Figueredo E. Dolor y analgésicos. Algunas consideraciones oportunas. Medisur [revista en Internet]. 2020 [citado 2020 Sep 7]; 18(4):[aprox. 11 p.]. Disponible en: http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4742.
8. Abella-Palacios P, Arias-Amézquita F, Barsella AR, Hernández-Porras BC, Narazaki DK, Salomón-Molina PA, et al. Control inadecuado del dolor agudo postoperatorio: prevalencia, prevención y consecuencias. Revisión de la situación en Latinoamérica. Rev Mex Anestesiol. 2021; 44 (3): 190-199. https://dx.doi.org/10.35366/99666
9. Blanco Naranjo E.G, Chavarría Campos G.F, Garita Fallas Y.M. Manejo multimodal del dolor crónico. Revista Médica Sinergia Vol. 6(4), abril 2021 - ISSN:2215-4523 / e-ISSN:2215-5279